SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH

Quản lý và tuân thủ quy trình kỹ thuật điều dưỡng

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVNT ngày / /2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân)

Mã: QĐ-A4.2 · Lần ban hành: 01

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng

Quy định việc xây dựng, thẩm định, ban hành, phổ biến, thực hiện, giám sát và cải tiến quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc điều dưỡng; áp dụng cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tại các khoa. Phác đồ điều trị, hội chẩn, chỉ định thuốc và cận lâm sàng do Phòng Kế hoạch tổng hợp và Hội đồng Thuốc và điều trị quản lý theo quy định riêng; Phòng Điều dưỡng phối hợp ở phần thực hiện y lệnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Quy trình kỹ thuật điều dưỡng: văn bản hướng dẫn các bước thực hiện một kỹ thuật thuộc Phụ lục XII Thông tư 32/2023/TT-BYT (đã sửa đổi).
- Kỹ thuật "*": kỹ thuật trong danh mục được đánh dấu "*", chỉ thực hiện khi có phân công bằng văn bản của người phụ trách chuyên môn (thời gian chuyển tiếp đến 31/12/2029).
- Sự cố liên quan điều dưỡng: sự cố có ít nhất một nguyên nhân thuộc khâu nhận định, thực hiện y lệnh, kỹ thuật, theo dõi, bàn giao hoặc báo cáo của điều dưỡng.

Chương II. XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH QUY TRÌNH

Điều 3. Danh mục kỹ thuật

Mỗi khoa lập danh mục kỹ thuật điều dưỡng đang thực hiện, đối chiếu Phụ lục XII, ghi rõ phân tầng "+", không đánh dấu, "*". Phòng Điều dưỡng tổng hợp danh mục toàn viện, trình Giám đốc phê duyệt và cập nhật trên phần mềm NT Nursing.

Điều 4. Biên soạn, thẩm định, ban hành

1. Khoa biên soạn theo mẫu quy trình chuẩn của bệnh viện: mục đích, phạm vi, trách nhiệm, chuẩn bị, các bước, tiêu chuẩn đánh giá, căn cứ, bảng kiểm kèm theo.
2. Phòng Điều dưỡng rà soát thể thức, căn cứ pháp lý; Hội đồng Điều dưỡng thẩm định nội dung bằng BM-A4.2-02.
3. Giám đốc ký ban hành; văn bản được đánh mã, số lần ban hành, ngày hiệu lực.

4. Mỗi quy trình phải có bảng kiểm giám sát; không ban hành quy trình chưa có bảng kiểm.

Điều 5. Phổ biến, lưu trữ

- Bản hiệu lực đăng trên phần mềm NT Nursing, có bản in tại khoa; bản hết hiệu lực được đánh dấu và thu hồi.
- Điều dưỡng trưởng tổ chức phổ biến cho nhân viên trong 30 ngày kể từ ngày ban hành, có danh sách ký nhận.

Điều 6. Rà soát

Quy trình được rà soát tối thiểu 02 năm một lần, hoặc sớm hơn khi: văn bản pháp luật, danh mục kỹ thuật thay đổi; có sự cố do quy trình; kết quả giám sát nhiều lần không đạt.

Chương III. THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT

Điều 7. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật

- Chỉ thực hiện kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn; kỹ thuật "*" phải có tên trong BM-A4.2-04.
- Kiểm tra an toàn trước kỹ thuật theo SOP-A4.2-01: xác định người bệnh bằng ít nhất 2 yếu tố, đối chiếu y lệnh, giải thích và cam kết khi cần, chuẩn bị vô khuẩn.
- Không làm tắt bước; ghi hồ sơ, ký xác nhận ngay sau khi thực hiện.
- Tuân thủ vệ sinh tay, kỹ thuật vô khuẩn theo Thông tư 16/2018/TT-BYT và quy định của Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Điều 8. Giám sát

- Điều dưỡng trưởng khoa: giám sát tối thiểu 05 lượt kỹ thuật/tháng bằng BM-A4.2-01, ưu tiên kỹ thuật nguy cơ cao và nhân viên mới.
- Phòng Điều dưỡng: giám sát hằng tháng theo kế hoạch, luân phiên các khoa; phối hợp Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Kết quả nhập trên phần mềm NT Nursing; khoa có tỷ lệ tuân thủ dưới 90% phải có kế hoạch khắc phục trong tháng.

Chương IV. KIỂM SOÁT SAI SÓT, CẢI TIẾN

Điều 9. Báo cáo sự cố

Nhân viên báo cáo sự cố, kể cả sự cố chưa xảy ra (near miss), theo quy định báo cáo sự cố y khoa của bệnh viện và Thông tư 43/2018/TT-BYT. Khuyến khích báo cáo tự nguyện, không quy lỗi cá nhân khi sự cố do lỗi hệ thống.

Điều 10. Phân tích nguyên nhân gốc và khắc phục

- Mọi sự cố liên quan điều dưỡng được phân tích theo SOP-A4.2-02 và BM-A4.2-03.
- Sự cố mức trung bình, nghiêm trọng: phân tích nguyên nhân gốc đầy đủ, có nhóm phân tích; sự cố nhẹ, chưa gây hại: phân tích rút gọn hoặc gộp theo nhóm cùng loại.

- Hành động khắc phục có người phụ trách, thời hạn, cách đo hiệu quả; Phòng Điều dưỡng theo dõi đến khi đóng.

Điều 11. Cải tiến

Hằng quý Phòng Điều dưỡng tổng hợp chỉ số tuân thủ, sự cố, kết quả khắc phục; đề xuất sửa quy trình, đào tạo lại hoặc giải pháp hệ thống (ví dụ: nhầm người bệnh thì chuẩn hóa xác định 2 yếu tố và vòng nhận dạng; chậm báo bác sĩ thì áp dụng tiêu chí báo động sớm).

Chương V. TRÁCH NHIỆM

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện

- Trưởng phòng Điều dưỡng: quản lý danh mục, tổ chức thẩm định, giám sát, phân tích sự cố liên quan điều dưỡng, báo cáo chỉ số.
- Hội đồng Điều dưỡng: thẩm định quy trình; xem xét kết quả phân tích sự cố nghiêm trọng.
- Trưởng khoa, Điều dưỡng trưởng khoa: lập danh mục kỹ thuật, phân công kỹ thuật "*", phổ biến, giám sát tại khoa.
- Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Quản lý chất lượng: phối hợp phân tích sự cố có yếu tố chẩn đoán, chỉ định, điều trị.
- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên: thực hiện đúng quy trình, báo cáo sự cố.

Điều 13. Hiệu lực

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

GIÁM ĐỐC